Correction de pédiatrie

INFAS Abengourou • Licence 3 • Diplôme blanc
12 octobre 2026 • Bloc B

Questions • Propositions • Réponses • Explications • Sources

La numérotation du sujet est conservée. Les questions 10, 21, 22 et 35 à 39 sont absentes du PDF fourni. La question 20 est partiellement coupée. Cette correction couvre les 46 questions visibles.

Références principales : COURS DE PÉDIATRIE(1).pdf, Licence 1 IDE/SF ; Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf, édition 2020. Dans ce dernier document, la page imprimée est décalée d'une page par rapport au compteur du PDF.

Pour les questions à choix doubles : A = Vrai ; B = Faux. Les réserves cliniques sont conservées pour les énoncés ne permettant pas une réponse absolue.

Questions à choix multiples

Question 1 — Dans la maladie hémorragique du nouveau-né

A. La race blanche est un facteur favorisant

B. L'allaitement est un facteur favorisant

C. L'accouchement facile est un facteur favorisant

D. Le lait artificiel est un facteur favorisant

Réponse : B

Explication : Le lait maternel contient peu de vitamine K. Le risque concerne surtout les nouveau-nés allaités exclusivement qui n'ont pas reçu la prophylaxie à la naissance. Cela ne remet pas en cause les bénéfices de l'allaitement.

Source : CDC, About Vitamin K Deficiency Bleeding. https://www.cdc.gov/vitamin-k-deficiency/about/

Question 2 — Pour préparer un biberon avec 210 ml d'eau, avec un lait dont la notice indique une mesurette rase pour 30 ml d'eau, j'utilise :

A. 4 mesurettes rase de lait

B. 5 mesurettes rase de lait

C. 6 mesurettes rase de lait

D. 7 mesurettes rase de lait

Réponse : D — 7 mesurettes

Explication : 210 ÷ 30 = 7. Mesurer l'eau avant d'ajouter la poudre. Ce calcul suppose une mesurette rase pour 30 ml d'eau ; la notice du lait utilisé reste la référence. Les 210 ml désignent ici le volume d'eau avant ajout de poudre.

Source : Calcul à partir du dosage précisé ; OMS, Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula. https://www.who.int/publications/i/item/9789241595414

Question 3 — JP, âgé de 36 mois, a un Z-score poids-pour-l'âge inférieur à −3. Cela signifie qu'il présente :

A. a un poids normal pour son âge

B. est en surpoids pour son âge

C. est obésité pour son âge

D. Une insuffisance pondérale sévère

Réponse : D — Insuffisance pondérale sévère

Explication : Le poids-pour-l'âge apprécie l'insuffisance pondérale. Il ne suffit pas à affirmer une malnutrition aiguë sévère, qui s'évalue notamment par le poids-pour-la-taille, le périmètre brachial et les œdèmes nutritionnels.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 127–128. OMS, classification de l'état nutritionnel des enfants, tableau 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK487900/table/fm.s1.t1/

Question 4 — PG, sexe masculin, 6 mois, 7kg a une diarrhée aiguë et boit avec avidité. Le pli cutané abdominal s'efface lentement et les yeux de PG sont enfoncés. Pour traiter PG, je lui administre durant les 4 premières heures de prise en charge

A. 450 ml de SRO

B. 350 ml de SRO

C. 550 ml de SRO

D. 525 ml de SRO

Réponse : D — 525 ml

Explication : Les signes décrits correspondent au plan B : 75 ml/kg de SRO en quatre heures. Calcul : 75 × 7 = 525 ml.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 88.

Question 5 — Nourrisson CB est âgé de 11 mois et pèse 11kg. Il présente des signes sévères de déshydratation. J'administre durant les 5 heures suivant la 1ère heure de traitement

A. 770 ml de soluté

B. 750 ml de soluté

C. 700 ml de soluté

D. 650 ml de soluté

Réponse : A — 770 ml

Explication : Avant un an, le plan C prévoit 30 ml/kg pendant la première heure, puis 70 ml/kg pendant les cinq heures suivantes. Calcul : 70 × 11 = 770 ml.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 89.

Question 6 — DF, garçon est né à terme eutrophique. La sage-femme vous informe que DF pèse 3420g au 3e jour de vie et qu'il a perdu 10% de son poids de naissance. Je déduis que le poids de naissance de DF était de

A. 3762 g

B. 3580 g

C. 3800 g

D. 3250 g

Réponse : C — 3 800 g

Explication : Après une perte de 10 %, les 3 420 g représentent 90 % du poids initial. Poids initial = 3 420 ÷ 0,90 = 3 800 g. Une perte de 10 % nécessite une évaluation de l'alimentation et de l'hydratation.

Source : Calcul à partir des données de l'énoncé ; connaissances complémentaires de néonatologie pour la surveillance pondérale.

Question 7 — Parmi les sources de difficultés du modèle conceptuel de Virginia Henderson listées ci-après se trouve un intrus. Cochez l'intrus

A. Manque de connaissance

B. Manque de vision

C. Manque de volonté

D. Manque de force physique

Réponse : B — Manque de vision

Explication : Les trois sources classiques sont le manque de force, de volonté et de connaissances. Un trouble visuel peut créer une dépendance, mais ce n’est pas l’une de ces trois catégories.

Source : Modèle conceptuel de Virginia Henderson, connaissances complémentaires en démarche de soins ; passage précis non retrouvé dans les cours consultés.

Question 8 — La bronchiolite aiguë du nourrisson dans sa forme commune non compliquée est provoquée

A. Une bactérie

B. Un virus

C. Un parasite

D. Champignon

Réponse : B — Un virus

Explication : La bronchiolite commune est principalement virale. Les antibiotiques ne sont pas systématiques dans sa forme non compliquée.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 101.

Question 9 — Pour traiter le nouveau-né présentant une infection bactérienne néonatale tardive le médecin utilise en priorité l'association

A. Ampicilline + aminoside

B. Chloramphénicol + aminoside

C. Azithromycine + aminoside

D. Ceftriaxone + aminoside

Réponse : D attendue dans la logique du cours de 2020, avec réserve

Explication : Le cours indique que les infections postnatales peuvent nécessiter une céphalosporine de troisième génération, sans établir que la ceftriaxone soit systématiquement adaptée à tout nouveau-né. Le choix dépend du foyer, d’une éventuelle méningite, du contexte nosocomial, des résistances et des contre-indications. L’OMS 2024 recommande notamment ampicilline + gentamicine pour certains sepsis hospitalisés du jeune nourrisson. L’énoncé manque donc de précisions pour imposer une réponse universelle.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 32–33. OMS, WHO recommendations for management of serious bacterial infections in infants aged 0–59 days, 2024, recommandation B.2. https://www.who.int/publications/i/item/9789240102903

Question 11 — Nourrisson CB, fille, 3 mois, réside à Daloa, présente toux quinteuse, geignement. CB est nourri au sein uniquement. Fréquence respiratoire 50 cycles/minute, diagnostic du médecin bronchiolite. Le diagnostic infirmier est :

A. Perturbation des échanges gazeux reliée à un manque de force physique

B. Dégagement inefficace des voies respiratoires reliée à un manque de force physique

C. Infection des poumons reliée à un manque de force physique

D. Détresse respiratoire reliée à un manque de force physique

Réponse : B — Dégagement inefficace des voies respiratoires, à confirmer

Explication : Cette proposition correspond le mieux à un diagnostic infirmier d’encombrement. Il faut rechercher les sécrétions et l’efficacité de la toux. Une perturbation des échanges gazeux demanderait des éléments supplémentaires, notamment la saturation en oxygène.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 101. Connaissances complémentaires pour la formulation du diagnostic infirmier.

Question 12 — Nourrisson CB, fille, 3 mois, réside à Daloa, présente toux quinteuse, geignement. CB est nourri au sein uniquement. Fréquence respiratoire 50 cycles/minute, diagnostic du médecin bronchiolite. L'objectif de soins de est de

A. Maintenir la fréquence respiratoire dans les limites de la normale (18-30 cycles/min) dans un délai de 1h après les soins.

B. Maintenir la fréquence respiratoire dans les limites de la normale (40-60 cycles/min) dans un délai de 1h après les soins.

C. Maintenir sa fréquence respiratoire dans les limites de la normale (30-40 cycles/min) dans un délai de 1h après les soins.

D. Maintenir sa fréquence respiratoire dans les limites de la normale (60-70 cycles/min) dans un délai de 1h après les soins.

Réponse : Aucune proposition ne permet une réponse unique suffisamment rigoureuse

Explication : L’objectif est d’obtenir une respiration efficace, avec diminution du geignement et des signes de lutte, et une fréquence adaptée à l’âge. Une fréquence de 50/min à elle seule ne suffit pas à qualifier la gravité. Évaluer aussi le repos, l’alimentation et la saturation. Ne pas imposer artificiellement une diminution à 30–40/min en une heure. Le référentiel cité donne une plage indicative de 25–60/min à trois mois chez l’enfant malade.

Source : Royal Children’s Hospital Melbourne, Acceptable ranges for physiological variables, ligne 3 months.
https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Acceptable_ranges_for_physiological_variables/

Question 13 — L'enfant qui souffre du Kwashiorkor

A. est apathique et grognon

B. aime jouer et jeter les objets

C. réclame à manger et boire

D. est constipé mais a l'appétit

Réponse : A

Explication : Le cours décrit un enfant adynamique, indifférent, hostile ou pleurnichard, avec diminution de l’appétit et œdèmes.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 125.

Question 14 — Selon la définition du cours, l’infection bactérienne néonatale précoce survient :

A. Pendant la première semaine de vie

B. J7 et J14 de vie

C. J14 et J21 de vie

D. J21 et J28 de vie

Réponse : A — Pendant la première semaine de vie

Explication : Le cours retient une survenue avant le septième jour. Certains référentiels utilisent une limite de 72 heures : il faut préciser la définition retenue.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 32.

Question 15 — KL, 6 mois, sexe masculin, fièvre à 40°Celsius. Il tolère sa fièvre si KL a

A. temps de recoloration cutané inférieur à 3 secondes

B. extrémités froides

C. teint grisâtre

D. geignement

Réponse : A

Explication : Un temps de recoloration inférieur à trois secondes est rassurant parmi les choix proposés. Extrémités froides, teint grisâtre et geignement sont des signes d'alerte. Un seul signe rassurant ne dispense pas de l'évaluation complète.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 59.

Question 16 — L'enfant né à terme eutrophique, allaité et correctement nourri quadruple son poids de naissance à :

A. 24 mois

B. 9 mois

C. 12 mois

D. 3 mois

Réponse : A — 24 mois

Explication : C'est un repère pédagogique approximatif. Le suivi individuel repose sur la courbe de croissance.

Source : COURS DE PÉDIATRIE(1).pdf — Licence 1 IDE/SF, p. 130.

Question 17 — À quel âge débute l'alimentation complémentaire du nourrisson ?

A. 24 mois

B. 18 mois

C. 16 mois

D. 6 mois

Réponse : D — 6 mois pour l'alimentation complémentaire

Explication : À six mois, les aliments complémentaires sont introduits avec poursuite de l'allaitement. Le mot « sevrage » est ambigu : le cours place le sevrage définitif à 24 mois ; l'OMS recommande l'allaitement jusqu'à deux ans ou au-delà.

Source : COURS DE PÉDIATRIE(1).pdf — Licence 1 IDE/SF, p. 101. OMS, Infant and young child feeding. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding

Question 18 — L'enfant à terme, eutrophique, nourri au sein exclusivement a comme acquisition à l'âge de 3 mois :

A. réflexes archaïques présents

B. dirige son regard dans les deux directions

C. a peur de l'étranger

D. S'assoit seul

Réponse : B

Explication : La poursuite visuelle se développe précocement. L’assise autonome et la peur de l’étranger apparaissent plus tard. Le cours situe à trois mois la tenue de tête et la disparition progressive des réflexes archaïques.

Source : COURS DE PÉDIATRIE(1).pdf — Licence 1 IDE/SF, p. 146. Connaissances complémentaires pour la poursuite visuelle.

Question 19 — Quel élément de l’échographie du premier trimestre permet de confirmer la vitalité embryonnaire ou fœtale ?

A. Estimer le risque d'hypoglycémie

B. Rechercher une malformation du fœtus

C. Vérifier la présence d'une activité cardiaque

D. Rechercher un retard de croissance intra utérin

Réponse : C — Présence d’une activité cardiaque

Explication : L’activité cardiaque confirme la vitalité. L’échographie du premier trimestre peut également dépister certaines malformations ; la formulation générale de l’énoncé ne rend donc pas B entièrement fausse.

Source : Assurance Maladie, Grossesse : le programme de suivi et la première consultation. https://www.ameli.fr/assure/sante/devenir-parent/grossesse/grossesse-en-bonne-sante/grossesse/grossesse-soins-dentaires-dentiste-consultation

Question 20 — Selon le cours, à quelle plage correspond une fièvre élevée ?

A. 37,5–38,5 °C

B. 38,5–40 °C

Réponse : B — 38,5 à 40 °C

Explication : Le cours distingue fièvre modérée, fièvre élevée et hyperthermie majeure au-delà de 40 °C. La proposition B reste identifiable malgré la coupure du PDF.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 58–59.

Question 23 — Les selles de la diarrhée aiguë provoquée par shiguelle sont

A. Pâteuses sans glaires ni sang

B. liquides avec des selles

C. Liquides sans selles

D. pâteuses avec des glaires et du sang

Réponse : D — Selles contenant des glaires et du sang

Explication : Une shigellose peut provoquer une dysenterie avec selles glairo-sanglantes. Le caractère « pâteux » n’est pas le critère déterminant.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 84.

Question 24 — Le principal germe de la diarrhée aiguë virale du nourrisson est

A. Coronavirus

B. Entérovirus

C. Rhinovirus

D. Rotavirus

Réponse : D — Rotavirus

Explication : C’est le virus dominant retenu dans le cours. Sa place épidémiologique peut évoluer avec la vaccination.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 83.

Question 25 — Parmi les avantages des soins mère-Kangourou listés ci-après se trouvent un intrus. Cochez l'intrus.

A. Favorise la prise de poids du nouveau-né

B. Favorise l'équilibre thermique du nouveau-né

C. Augmente la charge du travail du personnel

D. Renforce la confiance de la mère

Réponse : C

Explication : Une augmentation de la charge de travail n’est pas un avantage recherché. La méthode favorise la chaleur, l’alimentation au lait maternel et la participation parentale.

Source : OMS, Kangaroo mother care: a clinical practice guide. https://www.who.int/publications/m/item/kangaroo-mother-care--a-clinical-practice-guide

Question 26 — Les paramètres suivants sont les composants de la méthode de soins mère-Kangourou sauf un. Cochez l'intrus.

A. Aider bébé à respirer

B. Allaitement

C. Suivi

D. Contact peau à peau

Réponse : A

Explication : Les composantes classiques comprennent le contact peau à peau prolongé, l’alimentation au lait maternel et l’organisation du suivi. Une assistance respiratoire peut être nécessaire, mais elle n’est pas la définition de la méthode.

Source : OMS, Kangaroo mother care: a practical guide. https://www.who.int/publications/i/item/9241590351

Question 27 — Quel débit initial peut être utilisé pour une oxygénothérapie à faible débit par lunettes nasales chez un nouveau-né hypoxémique ?

A. 1 et 2L/min

B. 1 et 3L/min

C. 0,5 et 1L/min

D. 1 et 1,5L/min

Réponse : C — 0,5 à 1 L/min par lunettes nasales à faible débit

Explication : Cette réponse suppose des lunettes nasales à faible débit. Adapter l’oxygène à la saturation, à la gravité et au dispositif. Il n’existe pas de débit universel pour toute détresse respiratoire. Le cours ancien mentionne 2 L/min, ce qui explique une divergence possible avec une correction reposant uniquement sur celui-ci.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 25. OMS, Pocket Book of Hospital Care for Children, chapitre Problems of the neonate and young infant, oxygénothérapie. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK154443/

Question 28 — Le principal germe responsable de la bronchiolite aiguë du nourrisson est le

A. Rhinovirus

B. Coronavirus

C. Virus respiratoire syncytial

D. Paramyxovirus

Réponse : C — Virus respiratoire syncytial

Explication : Le VRS est le principal agent de bronchiolite retenu dans le cours.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 101.

Questions vrai ou faux

Question 29 — Pour confirmer le diagnostic de l'avitaminose K1 chez le nouveau-né qui saigne, je collabore avec le médecin pour réaliser un groupe sanguin ABO/Rhésus

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le groupage sert notamment à préparer une transfusion. Le déficit en vitamine K s’explore par le bilan de coagulation, notamment le temps de Quick/TP, généralement perturbé.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 45–46.

Question 30 — Une femme rhésus positif accouchant d'un enfant rhésus négatif reçoit du sérum anti D en intra musculaire

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La prophylaxie anti-D concerne une mère RhD négatif non immunisée exposée à des hématies fœtales RhD positif, selon les indications.

Source : Assurance Maladie, Comment se déroule une amniocentèse ou une biopsie de trophoblaste ?, prévention de l’immunisation Rhésus.
https://www.ameli.fr/assure/sante/examen/gynecologie/deroulement-amniocentese-choriocentese

Question 31 — Le nourrisson de 3 mois est capable de tenir sa tête dans l'axe

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La tenue de tête dans l’axe est attendue autour de trois mois, avec une variabilité individuelle.

Source : COURS DE PÉDIATRIE(1).pdf — Licence 1 IDE/SF, p. 146.

Question 32 — A 9 mois, le nourrisson est capable faire bravo, et au revoir

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai selon le tableau du cours

Explication : Ces gestes d’imitation figurent à neuf mois dans le document. Ils ne constituent pas une échéance identique pour tous les enfants.

Source : COURS DE PÉDIATRIE(1).pdf — Licence 1 IDE/SF, p. 146.

Question 33 — L’échographie du premier trimestre permet d’affirmer ou d’exclure une trisomie 21.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’échographie participe au dépistage, notamment par la clarté nucale. Elle ne permet pas à elle seule d’affirmer ou d’exclure une trisomie 21 et ne remplace pas un examen diagnostique chromosomique.

Source : Haute Autorité de santé, Dépistage de la trisomie 21. https://www.has-sante.fr/jcms/c_2899277/fr/depistage-de-la-trisomie-21

Question 34 — Le nouveau-né macrosome de sexe masculin à un poids en dessous de 4000g

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Dans la définition pondérale usuelle enseignée, la macrosomie correspond à un poids de naissance d’au moins 4 000 g. Le sexe masculin ne renverse pas ce seuil.

Source : Connaissances complémentaires de néonatologie ; le passage définissant précisément la macrosomie n’a pas été retrouvé dans les extraits consultés.

Question 40 — Le nourrisson de 9 mois manifeste de la peur devant un visage non familier.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La peur de l’étranger figure parmi les acquisitions de neuf mois.

Source : COURS DE PÉDIATRIE(1).pdf — Licence 1 IDE/SF, p. 146.

Question 41 — La déshydratation est une complication fréquente du marasme sévère

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La déshydratation peut être favorisée par la diarrhée et les autres pertes digestives. Son évaluation est délicate chez l’enfant sévèrement malnutri.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 129.

Question 42 — L'association Ceftriaxone + Aminoside est l'antibiothérapie probabiliste de première intention pour traiter l'infection bactérienne néonatale précoce

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le cours retient une pénicilline adaptée, notamment amoxicilline/ampicilline, associée à un aminoside. Le traitement exact dépend du tableau clinique et du protocole.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 32 et 37.

Question 43 — Les gestes septiques du personnel constituent le mécanisme caractéristique des infections néonatales précoces materno-fœtales.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux selon la distinction du cours

Explication : Les infections précoces sont principalement liées à une transmission materno-fœtale. Le cours rattache les mains et objets souillés aux infections postnatales. Toute contamination lors des soins reste dangereuse, quel que soit le jour d'apparition.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 33.

Question 44 — Une goutte épaisse et un frottis sanguin sont des tests réalisés et interprétés directement au lit du malade, sans microscopie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux pour une lecture directe au lit sans microscopie

Explication : Les prélèvements peuvent être effectués au lit, mais la lecture de la goutte épaisse et du frottis nécessite une microscopie. Le TDR est utilisable directement au point de soins. Goutte épaisse et frottis restent valables pour confirmer un paludisme si un laboratoire est disponible.

Source : OMS, Global Malaria Programme, Diagnosis — Microscopy. https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/case-management/diagnosis/microscopy

Question 45 — Le nouveau-né normal a un temps de recoloration cutané de 5 secondes

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Cinq secondes correspondent à un allongement anormal. Le cours considère un temps supérieur à trois secondes comme un signe d'alerte.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 34.

Question 46 — Le nourrisson présentant une déshydratation modérée est capable de boire :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Dans la déshydratation modérée, l'enfant boit souvent avec avidité. L'incapacité à boire est un signe de gravité.

Source : COURS DE PÉDIATRIE(1).pdf — Licence 1 IDE/SF, p. 158.

Question 47 — La coloration de référence du nouveau-né normal est décrite comme rouge-brun.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux selon le cours

Explication : Le document décrit une coloration rose. En pratique, tenir compte de la pigmentation et rechercher surtout pâleur, cyanose ou ictère.

Source : COURS DE PÉDIATRIE(1).pdf — Licence 1 IDE/SF, p. 30 et 32.

Question 48 — L’urée et la créatinine sanguines font partie du bilan prénatal systématique présenté dans le cours.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’urée et la créatinine ne figurent pas dans le bilan systématique du document. Elles peuvent être prescrites sur indication, notamment en cas de suspicion d’atteinte rénale.

Source : COURS DE PÉDIATRIE(1).pdf — Licence 1 IDE/SF, p. 27.

Question 49 — Un nourrisson de deux mois allaité, émettant habituellement trois à quatre selles molles par jour, a nécessairement une diarrhée.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Trois à quatre selles molles quotidiennes peuvent être physiologiques chez un enfant allaité. Rechercher une modification inhabituelle de leur fréquence ou de leur consistance et les signes associés.

Source : COURS DE PÉDIATRIE(1).pdf — Licence 1 IDE/SF, p. 156.

Question 50 — Le plan A de traitement de la diarrhée est indiqué pour la diarrhée sans signes de déshydratation

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le plan A concerne la diarrhée sans déshydratation : apports liquides adaptés, poursuite de l’alimentation et conseils de surveillance.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 88.

Question 51 — Lors de la diarrhée aiguë, le nourrisson de 3 mois reçoit en plus de la réhydratation et l'alimentation un comprimé de Zinc dosé à 20 mg par jour pendant 10 jours

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le cours indique pour cet âge un quart de comprimé de 20 mg, soit 5 mg/jour pendant dix jours. La recommandation OMS 2024 propose également 5 mg/jour, jusqu’à quatorze jours, pour la diarrhée aqueuse ou persistante. Le protocole national applicable doit guider la prescription.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 89. OMS, Guideline on management of pneumonia and diarrhoea in children up to 10 years of age, 2024, recommandation sur le zinc. https://www.who.int/publications/i/item/9789240103412

Question 52 — Le nourrisson souffrant d'une diarrhée avec signes évident de déshydratation est traité pendant les 4 premières heures au centre de santé

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le plan B prévoit 75 ml/kg de SRO en quatre heures, avec surveillance et réévaluation. L’aggravation impose de réévaluer immédiatement le traitement.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 88.

Question 53 — Pendant une diarrhée aiguë, le tube digestif conserve une capacité d’absorption permettant de poursuivre l’alimentation.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai pour la formulation ci-dessus

Explication : L’alimentation et l’allaitement doivent être poursuivis. Le chiffre « 50 à 70 % de la capacité » n’est pas établi par la phrase du cours, qui parle de « 50 à 70 % des cas » : ces formulations ne sont pas équivalentes.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 84.

Question 54 — Le nouveau-né prématuré âgé de 36 semaines d'aménorrhée stable est pris en charge au Centre de santé rural

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai sous conditions, selon le cours

Explication : Le cours autorise la prise en charge au premier contact d’un prématuré apparemment sain de 2 000 à 2 400 g, sans détresse respiratoire, avec surveillance adaptée. Le terme de 36 SA et le seul mot « stable » ne suffisent pas : vérifier alimentation, température, respiration et capacités du centre. Une complication impose la référence.

Source : Pédiatrie L2 IDE-SF.pdf — édition 2020, p. imprimée(s) 5.